جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فاطمة الزهراء عادل صديق بركات
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الزيتون **العنوان :** ----------
رقم البطاقة : 28002270101222 **رقم التليفون :** 01002829852 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 10-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 27-02-1980 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:(----------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فاطمة الزهراء عادل صديق بركات
National ID: 28002270101222

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

MDT form

Patient ID:
1- Name : Female Old Ref : 1222/2023

ID number: 28002270101222 Patient Age : 44 Y

Family history	-ve	Phone	01011143537	BMI		REASON OF MDT	
marital status		IMS Score		GROUP		Date of MDT	
Co morbidity	free	Menopausal status					

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
CTCAP-->FREE

BX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	Ki67 :
IDC	8/8	8/8	3		15

T	N	M
4b		0

Sonomammography
4/2023-->LT BREAST BIRADS6

PATIENT HISTORY
LT LABC RECEIVED 6 CYCLES OF TCHP LAST ONE ON 17/8/2023 WITH GOOD CLINICAL RESPONSE R WLE+ALND:y pT1 N0 free margins LN 0/12
partial pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

for continue 1 y of TDM1, PORT, AI/ zoladex 5 ys (contraception advised)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / فاطمه الزهراء عادل	Request No.	: 13005346
Patient No.	: 282002270101222	Request Date	: 05/04/2023
Path No.	: SR -429/2023	Verification Date	: 09/04/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نقابة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast mass
Nature of the specimen:
Slide revision
Gross Examination:
One paraffin block labelled as (737372) + Four Slides

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- IPT :

ER: Strong nuclear reaction in 20% of tumor cells (Allred score 6/8)
PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)
Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

Diagnosis:
Left breast mass , Slide revision :
- Invasive duct carcinoma grade II
- ER: Positive (6/8)
- PR : Positive (8/8)
- HER2 : Positive (score3+)
- Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

Prof.Dr.Gamal Abdelatty
Dr.Marwa Mahmoud

Verified by :
dr.esraa magdy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / فاطمه الزهراء عادل صديق	Request No.	: 13007611
Patient No.	: 28002270101222	Request Date	: 17/09/2023
Path No.	: 3132/23	Verification Date	: 07/10/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - تغطية الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.
Nature Specimen: Left breast wide local excision and left axillary lymph nodes.

Gross Examination:
* Left breast wide local excision specimen: A fibrofatty tissue measured 12x8x5 cm, with covering skin ellipse measured 11x4cm including nipple and areola .
* Tumor extent:
A clipped firm grayish white tumor bed site measured 1.3x1x0.5 cm.
A rubbery grayish white area measured 2x1x1 cm was found continouse with the clipped area .
* Skin involvement: Grossly unremarkable nipple and areola.
* Distance from margins: 2.3cm from deep margin , 2 cm from superior margin and 1.5 cm from skin .
* Left axillary lymph nodes : A fibrofatty tissue measured 4x3x2 cm entangling 12 nodes.

Microscopic Examination:
Left breast wide local excision and left axillary lymph nodes biopsy:
* Histological Type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- Maximal tumor diameter 0.7x0.7 cm
- Actual tumor cellularity: 30%, tumor necrosis index: 70%
* Ductal carcinoma in situ: Yes (5%)
* Skin involvement: Free nipple and areola .
* Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/12).
* Angioinvasion: No.
* Perineural invasion: No.
* Resection Margins: Free margins .
* Histologic response to therapy: Partial pathological response .

Verified by :

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / فاطمه الزهراء عادل صديق	Request No.	: 13007611
Patient No.	: 28002270101222	Request Date	: 17/09/2023
Path No.	: 3132/23	Verification Date	: 07/10/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - تغطية الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Diagnosis:
Left breast wide local excision and left axillary lymph nodes biopsy ,post NACT :
Invasive duct carcinoma , grade II with DCIS.
- Free margins.
- Free nipple and areola.
- Free lymph nodes 0/12.
- Partial pathological response.
- Stage: ypT1, ypN0
- RCB: 1.58, RCB class II .

Signature
Dr. Rana Fathy.
Dr. Sagda Elkady.

Verified by :

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

alfa
SCAN

Name: Fatma Al Zahraa Adel Seddik

ID: 3412844
Date: 13/04/2023

REPORT

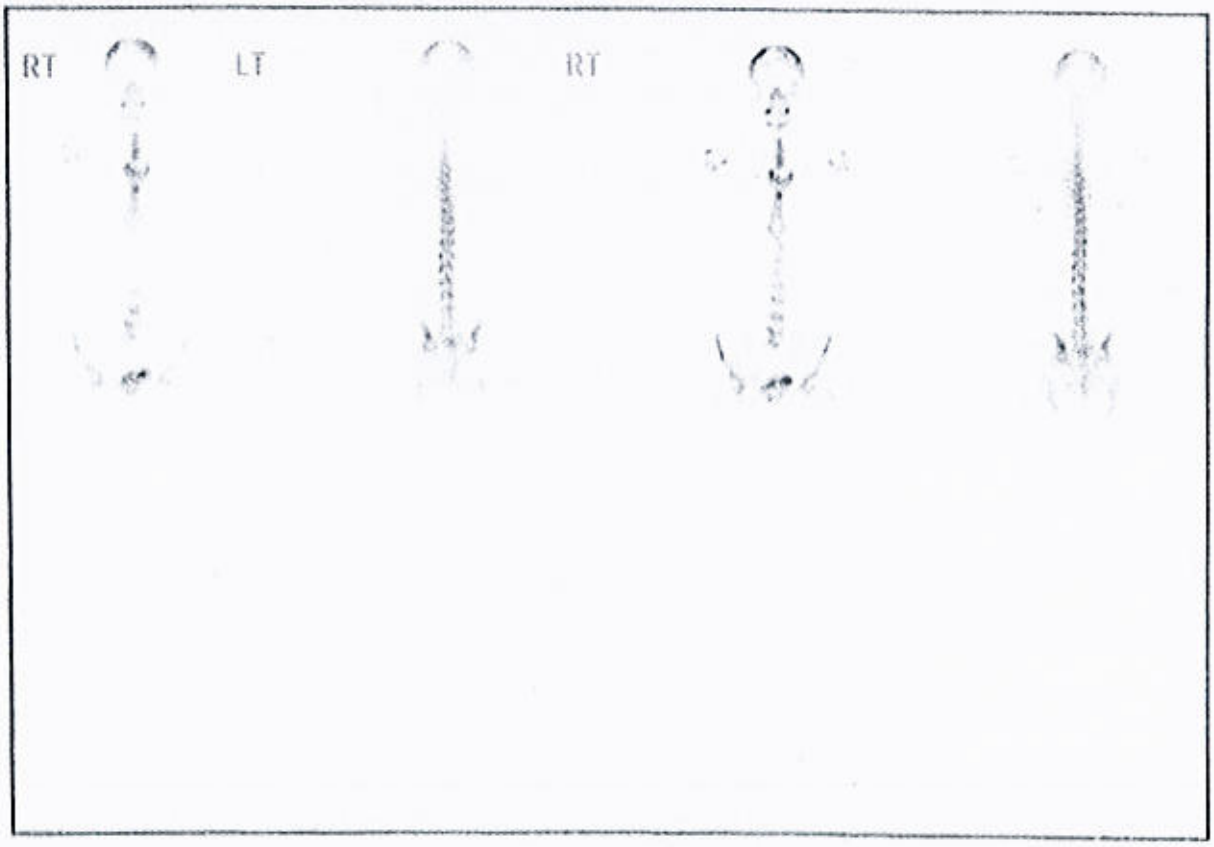
^{99m}Tc-MDP W.B. Bone Scan

Clinical data:

Complaint	History of left breast cancer.
Labs	Not available.
Trauma/surgeries	No
Previous imaging	Not available.
Previous bone scan	No

Technique:

Injected dose	740 MBq
Images	Delayed whole body.



alfa
S C A N

Findings:

- Uniform tracer uptake is noted by the scanned skeleton with no osseous lesions detected.
- Mild osteoarthritic changes of the knees are observed.

Impression:

- No scintigraphic evidence of metastatic osseous lesions.

Dr. Sherif El Refaei, MD, EBNM

Dr. Ferdaws Badr

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Fatma Al Zahraa Adel Seddik Barakat	Date : 12/01/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 1222/2023	Pat. ID: 32329

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Left breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed left breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no right breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Wafaa Ali

12/01/2025 2:20 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Fatma Al Zahraa Adel Seddik Barakat	Date : 05/04/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 43 Year(s)
Medical ID:	32329

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. ***Chest:***

- left breast UOQ irregular speculated mass lesion measuring 1.9 x 2.6 cm.
- left axillary level I enlarged lymph nodes the largest measures 1.3 x 1.5 cm.
- no sizable pulmonary nodules, masses or consolidations.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.
- Multiple calcified pelvic lesions seen related to the uterine surface, the largest measuring about 6.3 x 9.4 cm likely subserous fibroids.

3. ***The scanned skeleton:***

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]